

Fecha Última Actualización: 15-07-2022 13:26:57

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre : Juan Guillermo Arroyo Sáez

Edad : 31a 10m 25d

Dirección : Pedro Lagos 9285

Rut : 18.074.878-4

Fecha Nacto: 20/08/1990

Comuna : San Ramón

N° Archivo : 2204786

Sexo : Masculino

Teléfono : 974634344

N° Epicrisis

299539

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Emergencia Adulto

Fecha Ingreso : 15/03/2022 01:43

Días Estadía: 122

Unidad de Egreso : Medicina Básica (2do Piso)

Fecha Egreso : 15/07/2022 09:07

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Politraumatismo

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Epicrisis

15/007/22

Nombre: Juan Arroyo Saez

Edad: 31 Años

RUT: 18074878-4

FI CASR: 14/03/22

FI UCI: 15/03/22

FI Ag Quirúrgico: 13/04/22

F. Traslado a recuperación: 10/05/22

FI UCI: 11/05/22

FI PAM: 10/06/22

FI Sala: 14/06/22

ANTECEDENTES

1.Médicos: (-)

2.Quirúrgicos: (-)

3.Fármacos: (-)

4.Alergias:(-)

ANAMNESIS

Paciente ingresa al SU CASR traído por SAMU el 14/03/22 por accidente de tránsito en bicicleta contra auto, con mecanismo de alta energía. Estuvo hospitalizado en UCI desde el 15/03 al 13/04 con los siguientes diagnósticos:

1) Politraumatizado grave (15/03/2022)

2) VMI 15/03 - 03/04, weaning fallido con reintubación - TQT: 07/04/22

2) NAVM por S. Maltophilia (CAET 28/03) tratada

3) Meningitis por S. Epidermidis (PL 26/03) tratada

2) TEC grave (Captor de PIC 16/03 - 03/04)

Fecha Epicrisis : 15/07/2022 13:26

Página 1 de 5

Fecha Última Actualización: 15-07-2022 13:26:57

Página 2 de 5

- Fractura frontal multifragmentada
- HSA traumática
- Contusiones frontales bibasales
- Contusión occipital izquierda
- 3) Hemoneumotórax derecho y neumotórax izquierdo
- Fracturas costales derechas
- Contusión pulmonar
- 4) Fractura húmero, clavícula y escápula derecha
- 5) Fractura pierna derecha

Egres a agudo quirúrgico el 13/04 donde se describe desde el punto de vista de conciencia vigil, siguiendo órdenes simples. En dicha unidad se mantuvo en rehabilitación, a la espera de resolución quirúrgica de fractura de pierna derecha por equipo de traumatología. Se decanula TQT el 04/05 tras lo cual inicia con requerimientos de soporte de O2 al alza, describiéndose en evoluciones de kinesioterapia con crépitos gruesos concomitantes.

El 10/05 es re trasladado a unidad de agudo quirúrgico, donde se describe en malas condiciones generales. Con mala mecánica ventilatoria y uso de musculatura accesoria. Taquicárdico hasta 150 lpm, polipneico 40 lpm y febril. Se intentó conexión a VMNI frustra de forma precoz. Se traslada ese mismo día durante la madrugada a recuperación y se realiza intubación en SIR, sedación profunda y conexión a VMI. Con requerimientos de DVA con NAD hasta 0.2 ug/kg/min.

Se realiza AngioTAC de tórax el 10/05 que evidencia atelectasia masiva de pulmón derecho asociado a abundantes secreciones bronquiales (probablemente neumonía) y derrame pleural que impresiona loculado. Innumerables lesiones nodulares difusas en pulmón izquierdo, sin TEP.

Día 11/05 reingresa a UCI para continuar manejo.

Ingresa en malas condiciones generales. Con requerimientos de NAD a 0.2 ug/kg/min, taquicárdico hasta 130 lpm. En VMI modo V/AC mal acoplado a ventilador con gatillos ventilatorios espontáneos bajo sedación con Fentanilo/Midazolam + BNM con Rocuronio. Se pancultiva con crecimiento (9 hr) en ambos HC de CGP.

DIAGNÓSTICOS DE REINGRESO UCI

1. Shock séptico de foco pulmonar v/s cutáneo.
 - a. Obs neumonía estafilocócica.
2. Falla respiratoria aguda.
3. Celulitis muñeca izquierda - no descartable artritis séptica de la articulación
4. Celulitis, necrosis cutánea y sub cutánea (obs compromiso muscular) de pierna derecha
5. Antecedentes.

EVOLUCIÓN UCI/PAM/Sala Basica

1. Hemodinámico: A su ingreso con NAD a 0.2 ug/kg/min con perfusión clínica y de laboratorio conservada. Con predictores de respuesta a volumen negativos. A la ecoscopia cardíaca con motilidad conservada de VI. Se realiza reanimación e inicia antibioterapia con Linezolid + Meropenem en contexto de shock séptico. Logra destetarse de DVA en forma paulatina, concomitante con mejoría clínica de hit infeccioso. Posteriormente autosostenida. En sala Basica 14/06 , HDN estable , bien hidratado y perfundido, evoluciona sin conflicto.

2. Respiratorio: Se realiza FBC de aseo 11/05 con estudio microbiológico al ingreso UCI. Destaca restos de tapón mucoso desplazado adyacente al bronquio fuente derecho que se retira con salida de abundante secreción purulenta. Rx. Tórax de control con reexpansión pulmonar. Luego con lenta mejoría, logrando suspender sedación y extubación exitos a el día 07/06. Posteriormente con buena mecánica respiratoria, aún con secreciones de aspecto purulento pero que logra expectorar con ayuda de aspiración y NBZ + kinesioterapia. En Sala básica , evoluciona sin disnea, sin requerimientos de O2.

3. Neurológico: Inicialmente se mantiene sedado en SAS 1 con Fentanilo/Midazolam, BNM con Rocuronio. Luego con mejoría clínica y de cuadro respiratorio se suspende BNM y se van disminuyendo sedantes en forma paulatina. Se logra extubar y suspender sedantes el día 07/06. Desde entonces vigil pero apático. Evaluado por psiquiatría con ajuste de terapia pero

Fecha Epicrisis : 15/07/2022 13:26

Página 2 de 5

Fecha Última Actualización: 15-07-2022 13:26:57

Página 3 de 5

sugiere revaluación por neurocirugía/neurología (04/04/22) para determinar necesidad de estudio por Sd Confusional persistente.

Actualmente Síndrome confusional resuelto, sin necesidad de BDZ, y en tto con Risperidona VO.

4. Infeccioso: Ingresa cursando shock séptico de foco pulmonar (foco cutáneo impresiona secundario) asociado a neumonía grave de probable etiología estafilocócica. Se rescatan ambos HCT (+) para Staphylococcus aureus MR. En contexto de gravedad del cuadro y dada mejor biodisponibilidad en parénquima pulmonar, se inicia Linezolid para cobertura dirigida, asociado a Imipenem para cobertura de BGN (empírico), que luego se cambia a Meropenem por pseudomona aeruginosa + E. Coli BLEE (CAET 11/05), completa 7 días de antibioterapia y luego continúa con Linezolid dado neumonía cavitada por SAMR (actualmente en día 32). Dado aumento de secreciones se toma nuevo CAET (31/05 y 01/06) que resultan ambos positivos para S. Maltophilia por lo que se agrega cotrimoxazol con el cual completa 7 días de terapia, con buena respuesta clínica aunque con persistencia de parámetros inflamatorios elevados.

En Sala básica, con peak febril, asociado a hipotensión que responde a volumen, elevación de PPII, con Urocultivo (+) para Klebsiella Pneumoniae Blee, se completa Tto 7 días de Meropenem. Evoluciona sin fiebre, sin focalidad infecciosa, sin conflicto al alta.

Cultivo de pesquisa KPC positivo (1407/22), sin clínica infecciosa. Mantener estricto aislamiento de contacto.

5. Traumatológico: Cursando celulitis peri articulación de muñeca izquierda, con área eritematosa asociado a flictenas. Evaluación por traumatología, a quienes les impresiona neumonía con origen de foco cutáneo, probable ESI a nivel de antebrazo distal. No impresiona artritis séptica, sino celulitis y flebitis. En relación a EID, lesión por presión en pierna media de mediana extensión. Compromiso hasta subcutáneo sobre músculo, sin claros signos de infección. Se mantiene en curación por equipo de enfermería de UCI con clara mejoría junto a terapia antibiótica. En relación a Fx húmero y clavícula ya consolidadas con callo óseo. Se encuentra pendiente resolución de fractura maléolo medial derecho, la cual estaba programada para día 10/05 pero sin pase anestesiología dado que se encontraba cursando hit infeccioso.

Actualmente paciente estable hemodinámicamente y con hit infeccioso controlado y en tratamiento antibiótico, se realiza interconsulta a traumatología quienes solicitan TAC de tobillo derecho para definir manejo. Se realiza Reducción y osteosíntesis de tobillo derecho 11/07, sin incidentes. Evaluación post quirúrgica, en condiciones de alta y control ambulatorio.

6. Renal: Oligoanúrico, cursa con falla renal que no requirió diálisis, probablemente de componente renal y prerrenal en contexto de sepsis. Con el control de la infección presenta mejoría de diuresis y función renal. Actualmente con función renal conservada.

7. Psiquiatría: Reevaluado una vez extubado impresiona delirium mixto, con plan de ir disminuyendo benzodiacepinas en forma paulatina e iniciar risperidona. Se reinicia tiamina y con plan de reducción y redistribución de dosis lorazepam a 0.5mg -0.5mg -1mg EV. Evaluar reducción de dosis BDZ en un 20% cada 48 hrs. SOS: En caso de agitación franca, Haloperidol 2,5 mg + lorazepam 2 mg IM. Durante evolución en sala básica, decalaje de BDZ, sin agitación psicomotora, cooperador y adecuado.

Diagnósticos de Egreso

Fractura tobillo derecho ¿ Operado 11/07/22

Sepsis Foco Urinario ¿ Klebsiella Pn BLEE Tratada

Politraumatizado grave (15/03/22): Fractura maleolar derecha resuelta; TEC grave (Captor de PIC 16/03 -- 03/04); Fractura frontal multifragmentada; HSA traumática; Contusiones frontales bibasales, occipital izquierda, Hemoneumotórax derecho y neumotórax izquierdo, resueltas; Fracturas costales derechas, Contusión pulmonar, fractura húmero, clavícula y escápula derecha consolidadas (callo óseo)

Crítico crónico:

- Desnutrición calórica proteica severa en Tto.
- VMI prolongada (11/05 -07/06)
- Hospitalización prolongada (desde 14/03)

Shock séptico por neumonía cavitada por SAMR + E coli BLEE + PSAE BLEE (11/05), en resolución

- Obs 2a foco cutáneo (celulitis muñeca)
- Meropenem 7 días (01/06)

Fecha Epicrisis : 15/07/2022 13:26

Página 3 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:13

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 15-07-2022 13:26:57

- Linezolid día 40
- Empiema pleural derecho, drenado

Absceso cerebral frontal resuelto

AKI KDIGO 2, resuelta

Delirium mixto multifactorial persistente

Infecciosas resueltas:

- NAVM por S. Maltophilia (CAET 28/03) tratada, cotrimoxazol 7 días
- Meningitis por S. Epidermidis (PL 26/03) tratada

INDICACIONES

Reposo Relativo asistido

Régimen Blando sin grano

KNT Motora y respiratoria

Prevención UPP

Medicamentos:

B Ipratropio 2 puff cada 8hr x AC

Omeprazol 20 mg c/24 hrs VO

Paracetamol 1 g c/8 h VO

Metamizol 300 mg cada 8 hr VO

Risperidona 1 mg c/12 h VO

Manejo activo

Plan de hospitalización domiciliaria: Rehabilitación integral (Principalmente Kinesioterapia)

Diagnóstico de Egreso

Neumonía Asociada A Ventilación Mecánica (Navm) - S. Maltophilia

Meningitis - S. Epidermidis

Traumatismo Encéfalo Craneano Abierto - Fractura Frontal

Hemorragia Subaracnoidea Traumática -

Contusión Miocárdica -

Contusiones Hemorrágicas Cerebrales -

Neumotórax - Bilateral

Fractura De Miembro Inferior, Nivel No Especificado -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J:NO

Estable, en plan de continuar rehabilitación por hospitalización domiciliaria.

Plan Post Alta

INDICACIONES

Reposo Relativo asistido

Régimen Blando sin grano

KNT Motora y respiratoria

Prevención UPP

Medicamentos:

B Ipratropio 2 puff cada 8hr x AC

Omeprazol 20 mg c/24 hrs VO

Paracetamol 1 g c/8 h VO

Metamizol 300 mg cada 8 hr VO

Risperidona 1 mg c/12 h VO

Manejo activo

Fecha Epicrisis : 15/07/2022 13:26

Plan de hospitalización domiciliaria: Rehabilitación integral (Principalmente Kinesioterapia)

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Con 200 G De Hidratos De Carbono

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Camilo San Martín Ojeda

Becado/Residente



Camila Montoya Figari

Médico Tratante (Staff)